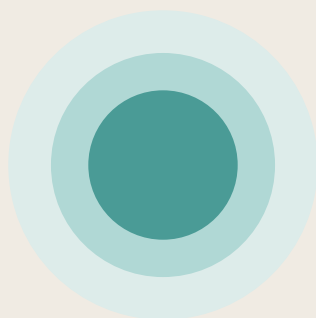




A Tua Saúde em Dia

O checklist anual da mulher portuguesa



Exames, rastreios e consultas
que não podes ignorar

Guia gratuito • consultas-online.pt





Para ti, que cuidas de todos menos de ti própria.

Sabes quando foi a tua última mamografia? E a última citologia cervical? Já fizeste o rastreio de colesterol este ano? E a tensão arterial?

A maioria das mulheres portuguesas adia os seus próprios cuidados de saúde porque está demasiado ocupada a cuidar de toda a gente. Do trabalho. Dos filhos. Da casa. Da família.

Segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), as mulheres são as maiores utilizadoras dos serviços de saúde — mas frequentemente em nome de outros, não de si próprias. São elas que levam os filhos ao pediatra, os pais ao médico, o marido à consulta. E ficam para o fim da lista.

Este ebook é para ti. Um guia simples, organizado e baseado nas recomendações da Direção-Geral da Saúde (DGS) e das principais sociedades médicas europeias, com todos os exames, rastreios e consultas que deves fazer regularmente — para que nunca mais te esqueças de cuidar da pessoa mais importante: tu mesma.

Como usar este guia

Imprime ou guarda no telemóvel. Marca com um visto cada item que já fizeste.

Usa como referência no início de cada ano — ou no teu mês de aniversário, que é mais fácil de lembrar. Revê anualmente e actualiza conforme a tua idade.

Em caso de dúvida, consulta sempre a tua médica.

Não tens médico de família? Não es a única.

Mais de 1,5 milhões de portuguesas estão na mesma situação.
Podes resolver muito por videoconsulta em consultas-online.pt

Checklist para todas as mulheres adultas

Independentemente da idade — a rever todos os anos

Avaliação Geral de Saúde

A avaliação geral anual permite detetar precocemente alterações que, tratadas a tempo, têm muito melhor prognóstico. Não precisa de ser uma consulta longa — uma videoconsulta de 15 minutos é suficiente para rever os teus valores e identificar o que requer atenção.

- ☐ **Tensão arterial — medição anual obrigatória a partir dos 18 anos**
A hipertensão afeta 42% dos adultos portugueses e é assintomática na maioria dos casos
- ☐ **Análises gerais: hemograma, glicemia em jejum, colesterol total e frações, triglicéridos**
Pedir ao médico um perfil lipídico completo — não apenas o colesterol total
- ☐ **Função tiroideia (TSH) — especialmente se fadiga inexplicada, alterações de peso ou humor**
As doenças da tiróide são 5-8x mais frequentes nas mulheres do que nos homens
- ☐ **Vitamina D — deficiente em 70% dos portugueses**
Pedir doseamento anual, especialmente no inverno
- ☐ **Ferro e ferritina — rastreio de anemia ferropénica**
Muito comum em mulheres em idade fértil devido à menstruação
- ☐ **Peso, IMC e perímetro abdominal**
O perímetro abdominal é um indicador de risco cardiovascular mais preciso que o IMC

Saúde Ginecológica

A saúde ginecológica é frequentemente adiada por vergonha, falta de tempo ou por não ter médico de família. No entanto, é uma das áreas onde o rastreio precoce faz maior diferença — nomeadamente na deteção de cancro tratáveis.

- ☐ **Citologia cervical (Papanicolau) — dos 25 aos 60 anos, cada 3 anos**
Em Portugal está incluída no Programa Nacional de Rastreio Oncológico — é gratuita
- ☐ **Autoexame da mama — mensalmente, entre o 7.º e 10.º dia do ciclo**
80% dos nódulos mamários são descobertos pelas próprias mulheres
- ☐ **Consulta de ginecologia anual**
Inclui avaliação pélvica, revisão do método contraceutivo e rastreio de IST
- ☐ **Rastreio de IST se vida sexual ativa**
VIH, sífilis, gonorreia e clamídia — pode ser pedido de forma discreta por videoconsulta

Saúde Mental e Bem-estar

A saúde mental é frequentemente a última prioridade da mulher portuguesa. O stress crónico, o burnout e a ansiedade têm impacto direto na saúde física — e merecem a mesma atenção que um exame de sangue.

- ☐ **Avaliação de níveis de stress, ansiedade e humor**
Usa escalas simples como o PHQ-9 (depressão) ou GAD-7 (ansiedade) — disponíveis online
- ☐ **Qualidade do sono — avaliar com a médica se há insónia ou sono não reparador**
A privação crónica de sono está associada a obesidade, diabetes e doença cardiovascular
- ☐ **Sinais de burnout — esgotamento emocional, distanciamento, perda de motivação**
O burnout é reconhecido pela OMS como fenómeno ocupacional desde 2019
- ☐ **Avaliação do consumo de álcool e tabaco**
O consumo de álcool nas mulheres portuguesas aumentou 18% na última década

Saúde Dentária

A saúde oral está diretamente ligada à saúde cardiovascular, metabólica e respiratória. A periodontite (inflamação das gengivas) é considerada um fator de risco independente para doença cardiovascular.

- ☐ **Consulta de dentista e higiene oral profissional — mínimo 1 vez por ano**
Idealmente de 6 em 6 meses se tiveres gengivas sensíveis ou tendência para tártaro
- ☐ **Radiografia panorâmica — cada 3-5 anos ou conforme indicação**
Permite detetar problemas não visíveis como quistos, impactações ou perda óssea

Saúde Visual

As alterações visuais são graduais e muitas vezes não percebidas. A deteção precoce de glaucoma, por exemplo, pode evitar a perda irreversível de visão.

- ☐ **Consulta de oftalmologia — cada 2 anos até aos 40; anual a partir daí**
A partir dos 40 anos aumenta o risco de glaucoma, cataratas e degenerescência macular
- ☐ **Atualização de óculos ou lentes de contacto — sempre que a visão alterar**

Prepara a tua pasta de saúde

Guarda num só lugar (pasta física ou app) os resultados dos teus últimos exames, relatórios de consultas, lista de medicação e alergias. Partilha com a tua médica na próxima consulta — mesmo que seja por videochamada.

Checklist por faixa etária

A adicionar ao checklist geral, conforme a tua idade

Dos 20 aos 30 anos — A base de tudo

Esta é a década de formar hábitos que durarão a vida toda. O teu estado de saúde nesta fase define, em grande parte, o teu ponto de partida para as décadas seguintes. É também a fase de maior risco de IST e de início da contraceção.

- ☐ **Primeira citologia cervical aos 25 anos**
O HPV é a IST mais comum no mundo; a citologia deteta alterações precoces no colo do útero
- ☐ **Vacina HPV — se ainda não tomou, até aos 26 anos (ou conforme indicação médica)**
Protege contra os serotipos 16 e 18, responsáveis por 70% dos cancro do colo do útero
- ☐ **Rastreio de IST se vida sexual ativa — VIH, sífilis, clamídia, gonorreia**
A clamídia é frequentemente assintomática e pode causar infertilidade se não tratada
- ☐ **Avaliação e escolha do método contraceutivo com médica**
Há mais de 10 tipos de contraceção — a escolha deve ser personalizada
- ☐ **Análises de base: hemograma, ferro, ferritina, vitamina D, tiróide (TSH)**
Muitas mulheres chegam aos 30 anos sem nunca terem feito análises completas
- ☐ **Avaliação da saúde mental — ansiedade e depressão são mais comuns nesta faixa**
A depressão é 2x mais frequente nas mulheres do que nos homens
- ☐ **Vacinação em dia — verificar calendário vacinal do adulto**
Tétano, difteria e tosse convulsa (dTpa) — reforço se passaram mais de 10 anos

Pílula anticoncecional: o que deves saber

Se tomas a pílula, a avaliação anual é essencial. Aos 30 anos, muitas mulheres precisam de reavaliar o método — por alterações de peso, tensão arterial ou hábitos. Podes fazer esta avaliação por videoconsulta em consultas-online.pt.

Dos 30 aos 40 anos — A década da acumulação

A terceira e quarta décadas de vida são frequentemente as mais exigentes para a mulher portuguesa — carreira, filhos, família. É também quando começam a aparecer os primeiros sinais de desregulação hormonal, metabólica e de saúde mental.

- ☐ **Citologia cervical — cada 3 anos (entre os 25 e os 60)**
Se o resultado foi sempre normal, pode fazer teste HPV em vez de citologia a partir dos 30
- ☐ **Avaliação de fertilidade — se planeamento de gravidez a médio prazo**
A reserva ovária diminui significativamente a partir dos 35 anos
- ☐ **Controlo de tensão arterial, colesterol e glicemia**
O risco cardiovascular aumenta progressivamente a partir dos 35 anos
- ☐ **Avaliação da função tiroideia (TSH, T4L)**
A tiroidite de Hashimoto tem pico de incidência entre os 30 e os 50 anos
- ☐ **Ecografia pélvica — se sintomas como dores pélvicas, períodos irregulares ou abundantes**
Permite rastrear miomas, quistos ovários e endometriose
- ☐ **Rastreio de diabetes gestacional — se gravidez planeada ou em curso**
- ☐ **Avaliação de saúde mental — burnout, ansiedade, síndrome pós-parto**
A depressão pós-parto afeta 10-15% das mulheres e é frequentemente subdiagnosticada

Dos 40 aos 50 anos — A transição hormonal

A perimenopausa pode começar até 10 anos antes da menopausa. Os sintomas são variados — irregularidade menstrual, afrontamentos, alterações de sono, humor e concentração — e merecem atenção médica.

- ☐ **Mamografia — a partir dos 45-50 anos, de 2 em 2 anos (Programa Nacional SNS)**
Se tens história familiar de cancro da mama, pede avaliação a partir dos 40 anos
- ☐ **Densitometria óssea — se fatores de risco para osteoporose**
Menopausa precoce, corticoides crónicos, baixo IMC são fatores de risco
- ☐ **Avaliação cardiovascular completa com ECG**
Após a menopausa, o risco cardiovascular da mulher iguala o do homem
- ☐ **Monitorização dos primeiros sinais de perimenopausa**
Afrontamentos, suores noturnos, irregularidade menstrual, secura vaginal
- ☐ **Avaliação hormonal — FSH, estradiol, se sintomas sugestivos**
- ☐ **Rastreio do cancro do cólon — pesquisa de sangue oculto nas fezes**
A partir dos 45 anos, de 2 em 2 anos — incluído no rastreio nacional

Dos 50 anos em diante — Investir na longevidade

Após a menopausa, o perfil de risco da mulher muda significativamente. A proteção hormonal que os estrogénios conferiam ao coração, ossos e cérebro deixa de existir. É por isso que a vigilância médica nesta fase é especialmente importante.

☐ **Mamografia — de 2 em 2 anos, pelo Programa Nacional de Rastreio Oncológico (SNS)**

Gratuita entre os 50 e os 69 anos — responde sempre à convocatória do SNS

☐ **Rastreio do cancro do cólon — pesquisa de sangue oculto nas fezes, cada 2 anos**

Em alternativa, colonoscopia cada 10 anos a partir dos 50

☐ **Citologia cervical — até aos 60 anos, cada 3 a 5 anos**

Pode ser suspensa após os 60 se os últimos 3 resultados foram normais

☐ **Densitometria óssea — rastreio de osteoporose**

Afeta 1 em cada 3 mulheres após a menopausa; frequentemente assintomática até à fratura

☐ **Avaliação cardiovascular anual — tensão, colesterol, ECG**

A doença cardiovascular é a principal causa de morte nas mulheres portuguesas

☐ **Avaliação cognitiva — memória e concentração**

A deteção precoce de declínio cognitivo permite intervenção mais eficaz

☐ **Controlo de glicemia — rastreio de diabetes tipo 2**

O risco aumenta significativamente após a menopausa

☐ **Oftalmologia — glaucoma, cataratas, degenerescência macular**

Todas têm tratamento mais eficaz quando detetadas precocemente

Vacinação do Adulto

☐ **Tétano, difteria e tosse convulsa (dTpa) — reforço a cada 10 anos**

Muitos adultos portugueses têm o reforço em atraso

☐ **Gripe — anual, especialmente a partir dos 65 anos ou com doença crónica**

Reduz o risco de hospitalização em 40-60% nos grupos de risco

☐ **Pneumocócica — a partir dos 65 anos ou com condição crónica**

Proteção contra pneumonia bacteriana, meningite e sépsis

☐ **COVID-19 — seguir recomendações atuais da DGS**

Sinais que nunca debes ignorar

Procura avaliação médica se tiveres qualquer um destes sinais

Os seguintes sinais podem ser sintomas de condições que requerem avaliação médica urgente. Não faças autodiagnóstico — procura orientação de uma profissional de saúde, mesmo que seja por videoconsulta.

- **Sangramento fora do período ou após a menopausa**
Pode indicar pólipos, miomas, hiperplasia endometrial ou cancro do endométrio
- **Nódulo ou alteração na mama — forma, textura ou cor da pele**
Embora 80% sejam benignos, todos requerem avaliação
- **Dor pélvica persistente, fora do período menstrual**
Pode indicar endometriose, quistos ováricos ou infeção pélvica
- **Corrimento com odor intenso, cor diferente do habitual ou com sangue**
Pode ser sinal de IST, vaginose bacteriana ou infeção fúngica grave
- **Perda de peso inexplicada — mais de 5% do peso corporal em 6 meses**
Sinal de alarme que requer investigação independentemente da causa
- **Fadiga extrema que não melhora com descanso**
Pode indicar anemia, disfunção tiroideia, diabetes ou depressão
- **Alterações súbitas no ciclo menstrual — duração, frequência ou quantidade**
- **Dor de cabeça intensa, súbita e diferente das habituais**
"A pior dor de cabeça da minha vida" — sinal de alarme neurológico
- **Ardor ou dor ao urinar, urgência frequente que não melhora**
Infeção urinária não tratada pode progredir para infeção renal
- **Alterações de humor intensas, ideação negativa ou isolamento social**
A saúde mental é saúde — e merece a mesma atenção que qualquer outro sintoma

Referências Bibliográficas

Este guia é baseado nas seguintes fontes de evidência científica

1. Direção-Geral da Saúde (DGS). Programa Nacional para as Doenças Oncológicas. Lisboa: DGS; 2022.
2. Direção-Geral da Saúde (DGS). Programa Nacional de Vacinação 2024. Lisboa: DGS; 2024.
3. Direção-Geral da Saúde (DGS). Orientação n.º 004/2021 – Contraceção Hormonal Combinada. Lisboa: DGS; 2021.
4. Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS). Programa Nacional de Rastreio Oncológico – Relatório de Atividade. Lisboa: ACSS; 2023.
5. Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA). Inquérito Nacional de Saúde com Exame Físico (INSEF). Lisboa: INSA; 2022.
6. World Health Organization (WHO). Medical Eligibility Criteria for Contraceptive Use, 5th edition. Geneva: WHO; 2015 (updated 2024).
7. Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare (FSRH). FSRH Guideline: Combined Hormonal Contraception. London: FSRH; 2023.
8. European Association of Urology (EAU). EAU Guidelines on Urological Infections. Arnhem: EAU; 2024.
9. Sociedade Portuguesa de Ginecologia (SPG). Recomendações para o Rastreio do Cancro do Colo do Útero em Portugal. Lisboa: SPG; 2021.
10. Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC). Prevenção Cardiovascular na Mulher – Recomendações. Lisboa: SPC; 2022.
11. Ordem dos Médicos. Regulamento de Boas Práticas em Telemedicina. Lisboa: OM; 2020.
12. Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março. Enquadramento Legal da Telemedicina em Portugal. Diário da República; 2020.
13. INFARMED. Normas de Prescrição Eletrónica de Medicamentos (Receita Sem Papel). Lisboa: INFARMED; 2023.
14. Sociedade Portuguesa de Medicina Interna (SPMI). Rastreio e Prevenção de Doenças Crónicas na Mulher Adulta. Lisboa: SPMI; 2023.
15. European Society of Cardiology (ESC). Guidelines on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227–3337.
16. World Health Organization (WHO). Mental Health Action Plan 2013–2030. Geneva: WHO; 2021.
17. Sociedade Portuguesa de Reumatologia (SPR). Recomendações para o Diagnóstico e Tratamento da Osteoporose. Lisboa: SPR; 2022.
18. European Menopause and Andropause Society (EMAS). Position Statement on Menopause and Cardiovascular Risk. Maturitas. 2023.
19. INSA. Programa Nacional para a Saúde Mental – Dados Epidemiológicos. Lisboa: INSA; 2023.
20. Fundação Portuguesa de Cardiologia. Factores de Risco Cardiovascular na Mulher Portuguesa. Lisboa: FPC; 2022.



Cuida-te como cuidas de toda a gente.

Sem médico de família? Sem problema.
Videoconsulta com médica disponível hoje.

● Baixa médica

● Pílula anticoncecional

● Atestados médicos

● Renovação de receitas

● Infecção urinária

consultas-online.pt

Segunda a domingo • 9h às 21h • A partir de 35€

